Plötzlicher Schock

Psychische Schäden bei Fahrlässigkeit im Recht von England und Wales. Die frühere Schockanforderung, Sion und Ronayne sowie die Korrektur durch Paul [2024] UKSC 1.

1. Die ältere Ausdrucksweise historisch einordnen

Ältere Entscheidungen beschrieben die Erkrankung eines Sekundäropfers häufig als Folge eines **nervous shock**: einer abrupten Reaktion auf ein gesehenes oder gehörtes belastendes Ereignis mit einem nahestehenden Menschen. Davon unterschieden die Gerichte die allmähliche Belastung beim Miterleben einer fortschreitenden Erkrankung.

In Alcock v Chief Constable of South Yorkshire Police [1992] 1 AC 310 beschrieb Lord Ackner Schock als plötzliche Wahrnehmung eines entsetzlichen Ereignisses, das den Geist heftig erschüttert. Spätere Urteile behandelten dies als eigenständige rechtliche Begrenzung. So lassen sich die alten Fälle verstehen; die Rechtslage nach 2024 wird damit aber nicht vollständig wiedergegeben. [1]

> **Heutige Regel:** Paul v Royal Wolverhampton NHS Trust [2024] UKSC 1 verwarf die zusätzliche Voraussetzung eines „plötzlichen Schocks des Nervensystems“. Ebenso wurde ein gesonderter Test verworfen, ob das Ereignis ausreichend „entsetzlich“ war. Beides darf nicht als zusätzliche heutige Anspruchsbedingung dargestellt werden. [1, Rn. 71-78]

2. Was bleibt erforderlich?

Für einen Anspruch wegen psychischer Erkrankung bleiben eine medizinisch anerkannte Krankheit und deren Verursachung durch die Pflichtverletzung erforderlich. Gewöhnliche Trauer, Angst oder Belastung allein genügt nicht. Das Leiden eines Angehörigen beweist nicht automatisch eine Diagnose; die eigene Erkrankung muss festgestellt werden.

Innerhalb der anerkannten Unfallgruppe gelten weiterhin Sorgfaltspflicht und Vorhersehbarkeit sowie die **Alcock-Kriterien**: enge Bindungen der Liebe und Zuneigung, zeitliche und räumliche Nähe zum Unfall oder seinen unmittelbaren Folgen und direkte Wahrnehmung statt bloßer Nachricht. [1]

3. Drei Fragen nicht verwechseln

Medizinisch: Welche Krankheit liegt vor? **Kausal:** Welche Erfahrung hat sie verursacht? **Rechtlich:** Besteht die maßgebliche Pflicht gegenüber dieser Person? Eine echte Krankheit kann auch bei erfolgloser Klage vorliegen. Mitgefühl allein beweist weder Erkrankung noch Haftung.

Hier geht es um psychische Schäden von Sekundäropfern. Die Unfallgrenzen werden nicht pauschal auf alle Kontexte übertragen, etwa eigene Ansprüche von Beschäftigten wegen arbeitsbedingter Belastung.

Die älteren medizinischen Fälle

4. Sion v Hampstead Health Authority (1994)

Sachverhalt: Ein junger Mann wurde bei einem Motorradunfall verletzt und im Krankenhaus behandelt. Sein Vater blieb vierzehn Tage an seinem Bett und erlebte Verschlechterung, Koma und Tod mit. Er behauptete, das Krankenhaus habe fortdauernde innere Blutungen pflichtwidrig nicht erkannt und dadurch den Tod sowie seine eigene psychische Erkrankung verursacht.

Wer wurde verklagt? Der Krankenhausträger, nicht der Verantwortliche des Verkehrsunfalls. Der Anspruch betraf die Behandlung und den Krankheitsverlauf im Krankenhaus. Er darf nicht als Klage wegen des Miterlebens des ursprünglichen Zusammenstoßes dargestellt werden.

Ergebnis: Die Klage wurde vorab ausgeschieden; der Court of Appeal bestätigte dies. Nach der damals verwendeten Schockanforderung beruhte die Erkrankung auf einem allmählichen Prozess, nicht auf einem plötzlichen Schockereignis. Beim Tod war dieser bereits erwartet worden. Die behauptete Behandlungsfahrlässigkeit wurde für diese Vorprüfung unterstellt, nicht nach vollständiger Beweisaufnahme festgestellt. [1, Rn. 62-63]

5. Liverpool Women’s Hospital NHS Foundation Trust v Ronayne

Fall: [2015] EWCA Civ 588. Fahrlässigkeit bei Frau Ronaynes Operation führte zu schwerer Erkrankung und Notfallbehandlung. Ihr Mann sah sie vor weiterer Operation an medizinische Geräte angeschlossen und später bewusstlos, beatmet und stark angeschwollen. Nach längerer Intensivbehandlung erholte sie sich schließlich.

Diagnose: Herr Ronayne behauptete PTBS. Der erstinstanzliche Richter verwarf diese Diagnose, nahm jedoch eine psychische Erkrankung an, die im Rechtsmittelverfahren als Anpassungsstörung behandelt wurde. PTBS war also nicht schon deshalb bewiesen, weil die Vorlage diese Bezeichnung verwendet.

Ergebnis: Zunächst gewann der Ehemann. Auf das erfolgreiche Rechtsmittel des Krankenhauses scheiterte sein Anspruch jedoch. Der Court of Appeal verwendete die ältere Schock- und Entsetzlichkeitsprüfung: Er sah eine Folge belastender Erlebnisse statt des geforderten plötzlichen Erlebnisses und bezweifelte die Kausalitätsanalyse. [2]

Heutige Verwendung: Zuerst das damalige Ergebnis erklären, dann Paul einordnen. Die alte Schockbegründung ist kein eigenständiger heutiger Test. Ihr Wegfall kehrt Ergebnisse nicht automatisch um und beweist nicht alle übrigen Voraussetzungen.

Die Rechtslage nach Paul

6. Paul: Kausalität ohne besonderen Schockmechanismus

Am 11. Januar 2024 stellte der Supreme Court klar: Die Schockbemerkungen in Alcock begründeten keine zusätzliche Haftungsbegrenzung. Es muss kein bestimmter neurologischer oder psychologischer Mechanismus bewiesen werden, durch den das Miterleben des Unfalls die Krankheit auslöste. Die ursächliche Verbindung selbst bleibt nachzuweisen. [1, Rn. 73-74]

Auch eine gesonderte Schwelle, wie „entsetzlich“ ein Ereignis sein muss, lehnte das Gericht ab. Davon verschieden ist die Frage, ob psychische Erkrankung in der Lage der klagenden Person vernünftigerweise vorhersehbar war. Der Wegfall des Zusatztests beseitigt nicht die Vorhersehbarkeit. [1, Rn. 75-78]

7. Späte Diagnose und allmähliche Belastung unterscheiden

Erfundenes Beispiel A: Eine Mutter sieht einen fahrlässig verursachten Unfall, bei dem ihr Kind schwer verletzt wird. Symptome zeigen sich danach; die Diagnose erfolgt Monate später. Die späte Diagnose allein schließt den Anspruch nicht aus. Erkrankung, Kausalität und alle übrigen Anforderungen bleiben zu beweisen.

Erfundenes Beispiel B: Ein Angehöriger erkrankt während wiederholter Besuche bei einem Patienten, dessen Krankheit sich über Wochen verschlimmert. Der Wegfall der Schockanforderung macht den Anspruch nicht automatisch erfolgreich. Sorgfaltspflicht, Unfallgrenze und übrige Bedingungen sind weiterhin zu prüfen.

> **Getrennt betrachten:** Zeitpunkt des Unfalls; Wahrnehmung des Unfalls oder unmittelbarer Folgen; Entwicklung der Krankheit; Zeitpunkt der Diagnose. Eine Diagnose muss nicht schon am Unfallort vorliegen.

8. Warum verloren die Familien in Paul trotzdem?

Der Supreme Court wies die Rechtsmittel in Paul, Polmear und Purchase zurück. Die Mehrheit erweiterte die anerkannte Unfallausnahme nicht auf das Miterleben der betreffenden medizinischen Krisen oder krankheitsbedingten Todesfälle nach früheren Diagnose- oder Behandlungsfehlern. Die Pflicht gegenüber dem Patienten umfasste hier nicht den entsprechenden Schutz der Familie. [1]

Das betrifft den Pflichtumfang, nicht die Echtheit der Erkrankungen. Ebenso wenig besagt es, dass medizinische Fahrlässigkeit niemals einen Unfall umfassen kann. Bei Sion und Ronayne ist daher zwischen der historischen Schockbegründung und der heutigen Pflichtprüfung zu unterscheiden.

Prüfungsmethode: Die ältere Schockbegründung benennen, Pauls Korrektur erklären und anschließend Erkrankung, Kausalität, Vorhersehbarkeit, relevanten Unfall und Alcock-Kriterien prüfen.

Verständnisfragen

1. Ist plötzlicher Schock eine zusätzliche heutige Voraussetzung für Sekundäropfer?
Antwort: Nein. Paul verwarf das eigenständige Erfordernis eines „plötzlichen Schocks des Nervensystems“.

2. Entfallen nach Paul medizinisch anerkannte Krankheit und Kausalität?
Antwort: Nein. Beides bleibt für einen Anspruch wegen psychischer Erkrankung erforderlich.

3. Wer war in Sion beklagt?
Antwort: Der Krankenhausträger. Es ging um behauptete Behandlungsfehler nach dem Motorradunfall, nicht um fahrlässiges Fahren dieses Beklagten.

4. Wie ging Ronayne aus?
Antwort: Der Ehemann gewann zunächst, verlor aber nach dem Rechtsmittel des Krankenhauses. PTBS wurde erstinstanzlich verworfen; im Rechtsmittelverfahren ging es um eine Anpassungsstörung.

5. Muss das Ereignis heute zusätzlich ausreichend „entsetzlich“ sein?
Antwort: Nein. Paul verwarf diesen Zusatztest. Die vernünftige Vorhersehbarkeit psychischer Erkrankung bleibt relevant.

6. Scheitert ein Unfallanspruch zwingend an einer erst Monate später gestellten Diagnose?
Antwort: Nein. Diagnosezeitpunkt und Verursachung durch den Unfall sind verschiedene Fragen. Alle übrigen Voraussetzungen bleiben wichtig.

7. Gewannen die Familien in Paul wegen des Wegfalls der Schockanforderung?
Antwort: Nein. Ihre Rechtsmittel scheiterten am Pflichtumfang und der Grenze der Unfallausnahme.

Der zentrale Gedanke

Historisch: Oft wurde ein plötzliches erschütterndes oder entsetzliches Ereignis verlangt.
Nach Paul: Diese Zusatztests entfallen; Krankheit, Kausalität, Vorhersehbarkeit und die anerkannten Grenzen der Sekundäropferhaftung bleiben.

Quellen und weiterführende Lektüre

[1] *Paul v Royal Wolverhampton NHS Trust; Polmear v Royal Cornwall Hospitals NHS Trust; Purchase v Ahmed* [2024] UKSC 1: Rn. 62-63 (Sion), 69-78 (Ronayne und die verworfenen Tests), 138-143 (ärztliche Pflicht und Ergebnis). Auch *Alcock* [1992] 1 AC 310 wird behandelt. Urteil des Supreme Court.

[2] *Liverpool Women’s Hospital NHS Foundation Trust v Ronayne* [2015] EWCA Civ 588, insbesondere Rn. 1-9 und 38-48. Urteil des Court of Appeal, The National Archives. *Sion v Hampstead Health Authority* [1994] 5 Med LR 170 wird in [1] erläutert.